

BIOSSEGURANÇA

Lisiane Silveira Zavalhia



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Biossegurança e gestão da qualidade

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer a importância da biossegurança no gerenciamento da qualidade em saúde.
- Identificar as normas e os critérios para a certificação e a acreditação de organizações de saúde.
- Definir alternativas de ação e de responsabilização que garantam segurança e qualidade nos serviços de saúde.

Introdução

O crescente e competitivo mercado das organizações prestadoras de serviços de saúde trouxe uma maior preocupação quanto à qualidade. Para que a melhoria seja estabelecida, é necessário adotar um sistema de avaliação de maneira contínua e sistematizada, de modo a melhorar progressivamente a qualidade, que é um requisito essencial para o sucesso de uma organização.

Neste capítulo, você vai conhecer a importância da biossegurança no contexto de gestão da qualidade em saúde. Também vai estudar as normas e critérios voltados para a acreditação e a certificação de organizações de saúde, além de saber quais são as alternativas de ação e responsabilização para garantir a segurança e a qualidade nos serviços de saúde.

Qualidade em saúde

A biossegurança é a ciência voltada para o controle e a redução dos riscos provenientes das práticas de distintas tecnologias. Sua premissa básica é assegurar o avanço tecnológico e científico e proteger a saúde humana, animal e do meio ambiente.

As ações de biossegurança devem ser consideradas no contexto da **gestão da qualidade**, cuja finalidade é garantir que atividades, produtos e serviços gerados em uma organização tenham a adequação que se espera.

Na atualidade, existem vários programas da qualidade disponíveis, que apresentam gradações diferentes de implantação e complexidade. Em qualquer ramo de atividade organizacional, a implantação propriamente dita se baseia em educação, treinamento, motivação e engajamento de todos os envolvidos, enfatizando que a matéria-prima humana seja a mais importante (HIRATA, M.; MANCINI FILHO; HIRATA, R., 2014).

A preocupação com a qualidade teve um aumento exponencial nos últimos anos, exigindo das empresas a utilização de técnicas mais eficientes e modernas de gestão. A competitividade entre as empresas resulta em uma busca por foco cada vez mais direcionado para o cliente e para a melhoria contínua, de forma que seus processos sejam conduzidos com base nos conceitos da qualidade. Para garantir a qualidade de produtos e serviços é necessária a adoção de sistemas de gestão da qualidade. Atualmente, o sistema de gestão da qualidade não tem mais caráter diferencial, mas sim um caráter de requisito básico para a melhoria da eficácia da gestão (PEZZATTO *et al.*, 2018).

Compreender como a qualidade é efetivada e como os distintos sistemas de avaliação são praticados, qual a percepção dos distintos atores sociais que estão envolvidos nesse processo e nos diferentes níveis de ação em saúde é um constante desafio para o gestor. Nesse campo, é imprescindível o entendimento do conceito de qualidade, tanto pelos que conduzem os processos assistenciais quanto por aqueles envolvidos na gestão (BONATO, 2011).

Quando falamos de qualidade em saúde, é importante destacar o nome de Avedis Donabedian, considerado o pai da qualidade no setor da saúde. Ele foi o pioneiro nesse setor e o primeiro autor que se dedicou, de maneira sistemática, a estudar e publicar sobre qualidade em saúde. Esse autor trouxe as noções de indicadores de estrutura, processo e resultado, adaptando-os ao atendimento hospitalar, e ampliou uma taxonomia utilizada para medir a qualidade da assistência. Tal taxonomia divide as medidas de qualidade em três elementos (WACHTER, 2013), acompanhe.

- Estrutura — Como o cuidado foi organizado?
- Processo — O que foi feito?
- Resultados — O que aconteceu com o paciente?

Juntos, esses três elementos são chamados de **triade Donabediana**. Quando eles são utilizados para avaliar a qualidade do atendimento, mostram vantagens e desvantagens importantes, como você pode observar no Quadro 1.

Quadro 1. Vantagens e desvantagens do uso da triade Donabediana para medir a qualidade do atendimento

Medida	Definição simples	Vantagens	Desvantagens
Estrutura	Como o cuidado foi organizado?	Pode ser altamente relevante em um sistema de saúde complexo.	Pode deixar de captar a qualidade do atendimento de médicos individualmente. É difícil determinar o “padrão ouro”.
Processo	O que foi feito?	Mais facilmente mensurável e passível de ação do que os resultados. Pode não necessitar de ajuste de <i>case-mix</i> . Pode refletir diretamente a qualidade (se cuidadosamente escolhido). Não há atraso de tempo — pode ser medido quando o cuidado é fornecido.	Uma referência para os resultados. Pode ser que nem todos concordem sobre quais processos são considerados “padrão-ouro”. Pode promover o “livro de receitas” da medicina, especialmente se os médicos e os sistemas de saúde tentarem “disputar” desempenho.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Vantagens e desvantagens do uso da tríade Donabedian para medir a qualidade do atendimento

Medida	Definição simples	Vantagens	Desvantagens
Resultado	O que aconteceu com o paciente?	O que realmente importa.	Pode levar anos para ocorrer. Pode não refletir a qualidade do tratamento. Requer <i>case-mix</i> e outros ajustes para evitar comparações de “maças com laranjas”.

Fonte: Adaptado de Wachter (2013).

O modelo de Donabedian pode ser utilizado para modificar uma unidade de prestação de cuidados de saúde e para avaliar os efeitos das mudanças sobre os indicadores externos de qualidade especificados. No entanto, o modelo em si não contém uma definição implícita de qualidade ou valor, mas é pertinente no que tange discussões sobre segurança e qualidade de atendimento ao paciente por dupla razão (BARASH *et al.*, 2017):

- a segurança do paciente relaciona-se com a estrutura e o processo, e a qualidade descreve os resultados e o modo pelo qual eles são realizados;
- legisladores, reguladores, gestores de saúde e pagadores uniformemente exigem e dependem dessa estrutura.

Dessa forma, o licenciamento de cada sistema de saúde, a conformidade regulatória, a condição de requisito de participação e a norma de credenciamento são, de alguma maneira, uma estrutura, um processo ou medida de resultado.

Resumidamente, Donabedian propôs que a estrutura influencia o processo e os processos influenciam os resultados (LARRABEE, 2011).

Documentação técnica

Em um panorama de suporte documental que reflete política, organização, ações, estratégias e instruções técnicas, encontra-se a **documentação técnica**. Essa documentação é parte essencial de um Sistema de Garantia da Qualidade, sendo capaz de possibilitar o rastreamento de todas as informações.

Tal documentação deve ser aprovada, assinada e datada pelo responsável técnico ou pessoa por este autorizada. As principais documentações técnicas são as seguintes (HIRATA, M.; MANCINI FILHO; HIRATA, R., 2014):

- **Manual da qualidade:** demonstra a política de qualidade da direção e a organização do serviço.
- **Procedimentos Operacionais Padrão (POP):** Oferece informações detalhadas de todos os passos necessários para realizar uma atividade, ou seja, é um roteiro padrão para que uma atividade seja realizada.
- **Manual de biossegurança:** deve conter instruções de biossegurança, os níveis de biossegurança das áreas/ambientes conforme os procedimentos realizados e equipamentos utilizados. Deve conter também normas e condutas de biossegurança, instruções para uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), procedimentos em ocasiões acidentais, manuseio e transporte de materiais biológicos.
- **Documentos gerais:** é um grande grupo de documentações em que consta registro de atividades, controles de qualidade, certificados, relatórios, formação de pessoal, registros de não conformidades, entre outros.

Qualidade total

A **gestão da qualidade total** aborda questões de qualidade em sistemas totais. A qualidade, no entanto, nunca é um objetivo final. O objetivo é levar ao mercado produtos de qualidade cada vez melhor, e não apenas a qualidade idêntica à de anos anteriores (KERZNER, 2016). Esse modelo de gestão da qualidade total teve como base os princípios defendidos por W. Edwards Deming, Joseph M. Juran e Phillip B. Crosby. W. Edwards Deming tornou-se famoso por seu papel transformador no Japão pós-guerra, que se tornou uma força dominante na economia mundial.

Os processos de gestão da qualidade total se baseiam no simples Ciclo de Deming — PDCA, em inglês, *Plan–Do–Check–Act*, ou Planejar–Executar–Verificar–Agir. O ciclo PDCA pode ser utilizado para identificar, validar e implementar melhores práticas em gestão de projetos, funcionando sob o seguinte panorama: inicialmente, planeja-se o que será executado e se executa; depois, o que foi feito é verificado e o que não funcionou será consertado; então se executa o que foi planejado inicialmente.

Esse ciclo, porém, não termina com a saída. Ele também funciona como um sistema de melhoria continuada, pois, quando o projeto se completa, tudo que foi aprendido no planejamento e execução é examinado, para que sejam incorporadas todas as lições ao processo. Assim reinicia o ciclo de planejar, executar, verificar e agir em um novo projeto.

A gestão pela qualidade total implica que todos os processos sejam monitorados e estejam sob controle, e essas atitudes formam a base para que tudo que for produzido não apresente defeito.

Programa 5S

O **programa 5S** traz uma essência prática e de fácil entendimento. Ele se baseia em educação, treinamento e prática de equipe, e modifica a maneira de ações e pensamentos das pessoas, trazendo melhorias no comportamento pessoal e profissional.

Com sua visão vinda do Japão, seu conceito é que, quando o funcionário se sente orgulhoso por ter estabelecido um ambiente de trabalho digno e está comprometido em melhorá-lo de modo contínuo, o 5S estará compreendido (HIRATA, M.; MANCINI FILHO; HIRATA, R., 2014). O 5S promove:

- prevenção de acidentes;
- ambiente de trabalho agradável;
- incentivo e criatividade no trabalho em equipe;
- melhoria moral dos funcionários;
- melhoria da qualidade;
- aumento da produtividade;
- redução de custos e consumo de energia;
- prevenção de pausas de máquinas por quebra;

Assim foi criada a base para implantação da qualidade total. O programa tem seu nome vinculado a 5 palavras japonesas iniciadas pela letra S e interpretadas como sentidos: *Seiri*, *Seiton*, *Seisou*, *Seiketsu* e *Shitsuke*. Esses sentidos constituem um sistema e, portanto, não devem ser isolados. A interpretação dos sentidos fica a cargo da organização, que fará adaptações para o seu contexto, considerando suas necessidades reais.

- **Seiri:** confere sentido de utilização, organização, arrumação, seleção e classificação.
- **Seiton:** confere sentido de ordenação, arrumação, organização e sistematização.
- **Seisou:** confere sentido de limpeza e inspeção.
- **Seiketsu:** confere sentido de saúde, higiene, asseio, padronização, conservação e manutenção aos três S anteriores.
- **Shitsuke:** confere sentido de autodisciplina, disciplina, educação, comprometimento, ética e moral.

Acreditação e certificação

A **acreditação** é definida como um procedimento da avaliação dos recursos organizacionais que é voluntário, periódico e reservado. Esse procedimento objetiva garantir a qualidade da assistência baseada em padrões previamente aceitos. Nesse processo, os setores e departamentos não são avaliados separadamente, mas sim são avaliados todos os serviços da organização (BONATO, 2011).

Ac creditação é um método de avaliação externa da qualidade dos serviços de saúde. Esse processo traz algumas vantagens, como:

- segurança para os pacientes e profissionais;
- qualidade assistencial;
- construção de equipe e melhoria contínua;
- critérios e objetivos concretos adaptados à realidade brasileira.

Além disso, é um útil instrumento de gerenciamento, sendo um caminho para a melhoria contínua.

Entretanto, a acreditação é um processo que implica custos para ser realizado. Existem três instituições atuando como acreditadoras no Brasil: a Organização Nacional de Acreditação; a Joint Commission International, representada pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação; e a Canadian Council on Healthcare Services Accreditation.

No ano de 1999, no intuito de coordenar o Sistema Brasileiro de Acreditação, foi instituída a **Organização Nacional de Acreditação (ONA)**, reconhecida como entidade competente para desenvolver o processo de acreditação hospitalar, de forma a implementar os padrões e normas técnicas, credenciando instituições acreditadoras e capacitando seus avaliadores. Em todo o processo de acreditação atuam o Ministério da Saúde e a ONA, responsáveis por desde habilitar as empresas acreditadoras até certificar os hospitais (OLIVEIRA, 2019).

Podem ser adotados e avaliados os padrões ONA nos seguintes tipos de prestadores de serviços de saúde:

- Hospitais.
- Ambulatórios.
- Laboratórios.
- Serviços de pronto atendimento.
- *Home care*.
- Serviços oncológicos.
- Serviços de medicina hiperbárica.
- Serviços de hemoterapia.
- Serviços de nefrologia e terapia renal substitutiva.
- Serviços de diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina nuclear.
- Serviços odontológicos.
- Serviços de processamento de roupas para a saúde.
- Serviços de dietoterapia.
- Serviços de manipulação.
- Serviços de esterilização e reprocessamento de materiais.

A instituição poderá ser acreditada ONA em três níveis: Nível 1, acreditado; Nível 2, acreditado pleno; Nível 3, acreditado com excelência.



Link

Acesse o site da ONA e veja, em mais detalhes, os três níveis de acreditação.

<https://qr.go.page.link/gwQ1e>

O **Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA)** visa à qualidade do cuidado ao paciente, à gestão administrativa e à otimização de produtividade. As atividades e os serviços são preestabelecidos, gerando protocolos e fluxos de atendimento a pacientes focados nos princípios de excelência alinhados com a segurança do paciente. O programa avalia a política institucional de segurança do paciente, salientando melhorias sustentáveis em qualidade e segurança, em especial na segurança do paciente. Esse processo de acreditação deve identificar as condições e práticas; salientar e corrigir os perigos para o paciente; incentivar o aumento de notificações; e reforçar a capacidade de reduzir riscos. Dessa maneira, o processo contribui para uma melhoria de qualidade continuada (WANDERLEI; MONTAGNA, 2018).

O processo de acreditação realizado pela **Joint Commission International (JCI)** busca estimular as organizações de saúde para que alcancem padrões de excelência na execução dos seus serviços por meio da implantação de padrões e da educação com foco na melhoria da qualidade assistencial. O objetivo do modelo da JCI é que organizações acreditadas demonstrem níveis de qualidade ótimos, ou seja, não apenas os padrões mínimos. Nesse processo de acreditação não existem níveis intermediários de acreditação (GRANDE; MENDES, 2015).



Fique atento

Certificado de acreditação: a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 é relacionada aos Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração. Já a ABNT NBR ISO 15189 é relacionada aos Laboratórios de Análises Clínicas.

Certificação

A **certificação** de uma atividade serve para comprovar a qualificação de itens, produtos, serviços, procedimentos, processos, pessoal ou sistemas de qualidade, no todo ou em parte. Essa certificação será executada por uma entidade com designação para tal (organismo certificador), baseada em requisitos já estabelecidos e documentados, e poderá resultar ou não na emissão de certificados (BONATO, 2011).

O conjunto de normas de qualidade mais utilizado e mais famoso é composto pela ISO (*International Organization for Standardization*), sendo a ISO 9000 e suas variantes as mais utilizadas (PEZZATTO *et al.*, 2018).

A expressão **ISO 9000** denomina um conjunto de normas técnicas, as quais estabelecem um modelo de gestão da qualidade para as organizações, qualquer que seja o seu tipo ou dimensão. O conjunto é composto pelas normas ISO 9000, 9001, 9004 e 19011. Elas podem ser aplicadas em vários tipos de organização — indústrias, empresas, instituições e afins —, e se referem apenas à qualidade dos processos da organização, e não dos produtos ou serviços. Esse conjunto de normas descreve regras relacionadas a implantação, desenvolvimento, avaliação e continuidade do Sistema de Gestão da Qualidade.

Para as organizações, adotar as normas ISO traz vantagens, considerando que lhes confere maior organização, produtividade e credibilidade. Esses elementos são facilmente identificáveis pelos clientes, o que faz com que haja um aumento da competitividade da organização nos mercados nacional e internacional (BONATO, 2011).

Veja quais são as normas do conjunto ISO 9000:

- **ISO 9001** — orientações sobre a qualidade dos projetos, seu desenvolvimento, produção, instalação e manutenção. Trata-se de uma das normas mais específicas, mostrando como deve ser cada processo da empresa.
- **ISO 9004** — orientações básicas para a implantação do sistema de gestão da qualidade.
- **ISO 19011** — diretrizes para auditorias de sistema de gestão.

Certificação ISO

Declaração emitida por um organismo de certificação credenciado, o qual irá atestar que a organização solicitante cumpre com os requisitos das normas ISO série 9000. Para que a organização solicitante seja certificada, ela precisa comprovar que conta com um sistema da qualidade já implantado e em funcionamento.

Mas como isso se comprova? Para a comprovação, é realizada uma auditoria de certificação, que é conduzida pelo organismo de certificação contratado, por meio da análise da documentação do sistema da qualidade (procedimentos, instruções de trabalho, documentos e registros da qualidade) e das evidências objetivas de sua implementação e funcionamento.



Saiba mais

O ISO foi criado em Genebra, na Suíça, no ano de 1947. É uma instituição sem vínculos governamentais, atuando para qualificar produtos, processos, materiais e serviços.

ISO 9001

Norma que define os requisitos para colocar um sistema de gestão da qualidade em vigor. Dessa forma, colabora para que as empresas aumentem sua eficiência e satisfação do cliente.

Esta certificação não é obrigatória; sendo assim, a organização deve avaliar se a certificação faz sentido para a sua empresa (BONATO, 2011).

A norma ISO 9001 apresenta 8 princípios da qualidade. São vários requisitos, que provêm das experiências de organizações, e que podem ser empregados por qualquer empresa que queira utilizar o sistema. Dessa forma, cada princípio deve ser analisado e estudado para que se atinja o sucesso na implantação do modelo.

Quadro 2. Diretrizes da ISO — Princípios de gestão da qualidade

Foco no cliente	Entender as necessidades presentes e futuras do cliente Atender aos requisitos do cliente Exceder as expectativas do cliente
Liderança	Manter a unidade de propósito e direção Manter um bom ambiente interno da organização Liderar pelo exemplo
Envolvimento das pessoas	Criar um ambiente de motivação Proporcionar a participação Aproveitar e valorizar o talento e as aptidões
Abordagem de processo	Gerenciar as atividades e recursos pertinentes como um processo, para garantir, com maior eficiência, o alcance dos resultados desejados
Abordagem sistêmica de gestão	Identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados, visando à eficácia da organização
Melhoria contínua	Buscar a melhoria com objetivo permanente
Enfoque factual para tomada de decisão	Tomar decisão eficaz baseada na análise de dados e informações
Relacionamento com os fornecedores para benefício mútuo	Estabelecer a base para criação de valor para as partes baseada no relacionamento “ganha-ganha”

Fonte: Adaptado de Bonato (2011).

A literatura infere que, além da acreditação, é possível observar um movimento em torno da certificação da ISO nos diferentes segmentos da saúde, especialmente nos hospitais. A maioria deles, inicialmente, opta por métodos de certificação, sendo o Sistema de Qualidade da Norma ISO 9000 o mais adotado por sua aplicação de caráter parcial, técnica e orientadora (BONATO, 2011).

OHSAS 18001

Para que as empresas sejam reconhecidas como seguidoras de padrões internacionais de qualidade na área de segurança e saúde do trabalhador, a certificação indicada é a OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assessment Specification*). Ela atesta o seguimento de boas práticas referentes à saúde e à segurança dos colaboradores.

Essa norma é utilizada em sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalhador, ajudando as organizações no controle dos seus riscos e, assim, na melhoria do seu desempenho nesse quesito.

Laboratórios de análises clínicas

Os laboratórios de análises clínicas são, também, empresas prestadoras de serviço da área da saúde, objetivando prestar auxílio diagnóstico.

Como você observou no decorrer deste capítulo, há um grande movimento no setor de saúde para implementar Sistemas de Gestão da Qualidade. Para que um laboratório de análises clínicas tenha um diferencial frente à grande disputa de mercado, é importante que ele obtenha uma acreditação. Esse é um desafio grande para um laboratório após ele ter implantado um sistema de gestão da qualidade.

Como vimos, e tomando como exemplo as normas ISO, o processo de certificação assegura que determinados produtos, processos ou serviços são executados conforme os requisitos especificados. Já na acreditação são avaliados os procedimentos com o propósito de verificar se eles estão adequados aos serviços oferecidos, além de se cumprem os requisitos exigidos em uma certificação, a exemplo da acreditação da ONA (VIEIRA *et al.*, 2011). Aqui no Brasil, quem realiza a coordenação geral de acreditação é o Inmetro, mas existem órgãos certificadores autorizados a atuar.

A acreditação de um laboratório de análises clínicas é concedida com base nas normas ABNT NBR ISO 14500, de 31 de julho de 2000, e ABNT NBR ISO 15189, de 9 de fevereiro de 2015. Os órgãos certificadores para laboratórios clínicos no nosso país são:

- **Departamento de Inspeção e Credenciamento da Qualidade (DICQ) da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC):** objetiva a acreditação do Sistema da Qualidade de Laboratórios Clínicos e de outras organizações prestadoras de serviços de saúde por meio de critérios e requisitos estabelecidos. São realizadas auditorias nos laboratórios clínicos, que servirão para avaliar o funcionamento do seu Sistema da Qualidade e da sua capacitação técnica para realizar exames laboratoriais.
- **Organização Nacional de Acreditação (ONA):** objetiva implantar um processo constante de avaliação e certificação de qualidade nos serviços de saúde, provendo capacitações, diagnóstico organizacional, avaliação e certificação. Lembrando que a ONA contempla três níveis de acreditação.
- **Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC) da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML):** esse programa define normas a serem cumpridas, específicas para o laboratório, que são: organização geral, segurança ambiental e biossegurança, gestão da qualidade, documentação da qualidade, atendimento ao cliente, equipamentos e reagentes, controle da qualidade analítica, laboratório de apoio, sistema de informação laboratorial e laudos.

Ensaio de proficiência

Nas décadas de 1970 e 1980 surgiram os programas de controle da qualidade em laboratório clínico, entre os quais podemos citar o Proficiência em Ensaio Laboratoriais (PELM) e o Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ).

Esses ensaios de proficiência são programas de comparação interlaboratorial dos resultados de análises qualitativas e quantitativas, ou seja, os laboratórios podem comparar seus resultados. Eles são considerados como uma ferramenta importante para a gestão do desempenho dos laboratórios no que tange seus processos analíticos.

Em períodos regulares durante o ano, agências de ensaios de proficiência enviam amostras cegas aos laboratórios, que as analisam e enviam seus resultados para as agências de ensaios de proficiência. Desse modo, os laboratórios podem comparar resultados e, assim, garantir a concordância dos laudos de um mesmo paciente em diferentes regiões (HIRATA, M.; MANCINI FILHO; HIRATA, R., 2014).

Indicadores de desempenho

Indicadores

A **Garantia da Qualidade** é parte essencial de um **Sistema de Gestão da Qualidade**, considerando que ela garante a qualidade do que está em processo de produção. Nos hospitais, por exemplo, é primordial que haja qualidade no atendimento aos pacientes para que o hospital seja escolhido para a certificação. Um esforço constante das organizações de saúde está voltado para garantir que haja qualidade em todos os processos de trabalho.

A certificação e a acreditação compõem metodologias de qualidade capazes de avaliar todos os serviços hospitalares em todos os setores. Nesse contexto, um programa de acreditação hospitalar deve promover melhorias estruturais, em processos e resultados, além de responsabilizar-se por medir o desempenho de uma organização por meio de indicadores (OLIVEIRA, 2019).

Um **indicador** pode ser caracterizado como um sensor capaz de auxiliar na verificação do cumprimento, ou não, dos objetivos propostos.

Os **indicadores de qualidade na área da saúde** correspondem a critérios para avaliar a qualidade da assistência à saúde a uma população, tanto em termos de procedimentos específicos quanto de uma rede de serviços. Alguns indicadores que podem ser citados são a taxa de infecção hospitalar em um hospital; o número de profissionais de saúde a atender uma população; o percentual de prescrições realizadas em um serviço de saúde (PORTELA, 2000).

A abordagem da garantia de qualidade está concentrada em elementos que são relevantes a cada um dos processos que se almeja monitorar em uma organização de atenção à saúde, satisfazendo-se com a observância dos padrões definidos para os indicadores considerados. Aprimorar continuamente não estipula limites para a qualidade a ser atingida. Conforme os níveis de melhoria na qualidade são atingidos, indicadores mais sensíveis às novas melhorias podem se fazer necessários (PORTELA, 2000).

Depois de definidos os indicadores, é necessário definir as **metas**, ou seja, deve ser determinado um valor/resultado que se deseja alcançar em certo espaço temporal e em condições preestabelecidas (OLIVEIRA, 2019).

A planilha de indicadores (PIN) é um documento que explicita os indicadores de cada setor, demonstrando os resultados de um hospital dentro de determinado período, e destaca o desempenho de setores. Sendo assim, os indicadores são parte fundamental, para que o sistema de gestão consiga compreender, controlar e identificar as melhorias necessárias (OLIVEIRA, 2019).

Criar indicadores é muito importante para avaliar a qualidade, pois propicia uma medida e permite o monitoramento e a identificação de oportunidades de melhoria de serviços e de mudanças positivas relacionadas ao alcance da qualidade (D'INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006).

Dimensões da qualidade na assistência à saúde

O Institute of Medicine (IOM) definiu a qualidade do atendimento da seguinte forma: trata-se do grau em que os serviços de saúde para indivíduos e populações aumentam a probabilidade de resultados de saúde desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual. No *Crossing the Quality Chasm* (Cruzando o Abismo da Qualidade), seu relatório de 2001, o IOM trouxe seis dimensões para um sistema de saúde de qualidade, o qual aborda (WACHTER, 2013):

- segurança do paciente;
- centralidade no paciente;
- eficácia;
- eficiência;
- oportunidade;
- equidade.

O IOM faz uma reflexão muito importante, pois considera a experiência do paciente como uma das principais dimensões de qualidade. As avaliações dessa experiência (as quais normalmente são coletadas por pesquisas com o próprio paciente) são importantes para mensurar a qualidade, pois elas refletem um resultado que nos importa, e porque esses pacientes podem ser capazes de identificar problemas de qualidade não observados por meio de outros métodos.



Exemplo

Um exemplo de indicador pode ser o número de cancelamento de cirurgias em um hospital. Essa taxa de cancelamento é um indicador de processo que expressa o grau de eficiência do centro cirúrgico de tal forma que, quanto menor for o índice de cancelamento das cirurgias, maior é o nível de excelência do serviço.



Referências

- BARASH, P. G. *et al.* *Fundamentos de anestesiologia clínica*. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- BONATO, V. L. Gestão de qualidade em saúde: melhorando assistência ao cliente. *O Mundo da Saúde*, v. 35, n. 5, p. 319–331, 2011. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Bonato-2011.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2019.
- D'INNOCENZO, M.; ADAMI, N. P.; CUNHA, I. C. K. O. O movimento pela qualidade nos serviços de saúde e enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 59, n. 1, p. 84–88, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n1/a16v59n1.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2019.
- GRANDE, R. de S.; MENDES, G. H. de S. Impactos da acreditação hospitalar pela Joint Commission International em um hospital brasileiro. *Revista Espacios*, v. 36, n. 20, p. 10, 2015. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a15v36n20/15362010.html>. Acesso em: 20 ago. 2019.
- HIRATA, M. H.; MANCINI FILHO, J.; HIRATA, R. D. C. *Manual de biossegurança*. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.
- KERZNER, H. *Gestão de projetos: as melhores práticas*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
- LARRABEE, J. H. *Nurse to nurse: prática baseada em evidências em enfermagem*. Porto Alegre: AMGH, 2011.
- OLIVEIRA, S. M. K. *Fundamentos de administração hospitalar e saúde*. Porto Alegre: SAGAH, 2019.
- PEZZATTO, A. T. *et al.* *Sistemas de controle da qualidade*. Porto Alegre: SAGAH, 2018.
- PORTELA, M. C. Avaliação da qualidade em saúde. In: ROZENFELD, S. (org.). *Fundamentos da vigilância sanitária*. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. p. 259–269. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/d63fk/pdf/rozenfeld-9788575413258.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2019.
- VIEIRA, K. F. *et al.* A utilidade dos indicadores da qualidade no gerenciamento de laboratórios clínicos. *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*, v. 47, n. 3, p. 201–210, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jbpml/v47n3/v47n3a02.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2019.
- WACHTER, R. M. *Compreendendo a segurança do paciente*. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. (Lange).
- WANDERLEI, P. N.; MONTAGNA, E. Formulação, desenvolvimento e avaliação de um curso a distância para acreditação em segurança do paciente. *Einstein (São Paulo)*, v. 16, n. 2, eGS4316, 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/eins/v16n2/pt_1679-4508-eins-16-02-eGS4316.pdf. Acesso em: 20 ago. 2019.

Leituras recomendadas

BARBOSA, L. O.; MANSOUR, S. N. Projeto de implantação da gestão da qualidade com base na norma PALC e metodologia ONA em um laboratório de análises clínicas. *RBAC: Revista de Análises Clínicas*, 2018. DOI: 10.21877/2448-3877.201800701. Disponível em: <http://www.rbac.org.br/artigos/projeto-de-implantacao-da-gestao-da-qualidade-com-base-na-norma-palc-e-metodologia-ona-em-um-laboratorio-de-analises-clinicas/>. Acesso em: 20 ago. 2019.

BRASIL. Sistema Nacional de Acreditação. *Manual para acreditação do sistema da qualidade de laboratórios clínicos*. 3. ed. Rio de Janeiro: DICQ, 2006. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/qualidade/MANUAL%20PARA%20ACREDITAO%20DO%20SISTEMA%20DA%20QUALIDADE%20DE%20LABORATORIOS%20CLNICOS.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2019.

CHAVES, C. D. Controle de qualidade no laboratório de análises clínicas. *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*, v. 46, n. 5, p. 352–352, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jbpm/v46n5/02.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2019.

DIAS, V. S.; BARQUETTE, F. R. S.; BELLO, A. R. Padronização da qualidade: alinhando melhorias contínuas nos laboratórios de análises clínicas. *RBAC: Revista de Análises Clínicas*, 2017. DOI: 10.21877/2448-3877.201700540. Disponível em: <http://www.rbac.org.br/artigos/padronizacao-da-qualidade-alinhando-melhorias-continuas-nos-laboratorios-de-analises-clinicas/>. Acesso em: 20 ago. 2019.

SILVA, P. H. da *et al.* *Hematologia laboratorial: teoria e procedimentos*. Porto Alegre: Artmed, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS. *PNCQ*. Brasil, 2015. Disponível em: <https://www.pncq.org.br/>. Acesso em: 20 ago. 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA. *Programas da qualidade*. Brasil, [2019]. Disponível em: <http://www.sbpc.org.br/programa-da-qualidade/ensaio-de-proficiencia/>. Acesso em: 20 ago. 2019.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS